

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA — CONTROL PRENATAL

Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo (sintético) — Consultorio Obstetricia

FILIACIÓN

Nombre:	Lucía Mendoza Quispe (SINTÉTICA - NO REAL)
DNI:	47812936
HC:	HCL-2024-08847
Edad:	28 años
Fecha consulta:	14/10/2024

ANTECEDENTES (resumen completo del embarazo)

Fórmula obstétrica: G2 P1 (parto vaginal previo 2019, RN 3,200 g sin complicaciones). Antecedente familiar DM2 (madre). Sobrepeso pre-gestacional (IMC 25.6). **Diabetes gestacional diagnosticada en sem 24** por PTOG alterada. **Inicio de dieta diabética** desde sem 24. **Inicio de insulina NPH** en sem 32 (10 UI nocturnas) por mal control con dieta. **Titulación progresiva**: actualmente 18 UI nocturnas + 8 UI matutinas. Promedio de glicemias últimas 2 semanas: ayunas 88 mg/dL, post-prandiales 128 mg/dL (CONTROLADAS).

GESTACIÓN ACTUAL

FUR:	27/12/2023
FPP:	03/10/2024
EG actual:	38 semanas + 2 días
Controles prenatales:	12 al momento
Movimientos fetales:	Presentes, ≥10/2 h

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

Peso actual:	82.4 kg (ganancia total 18.4 kg)
PA:	124/76 mmHg
FC:	84 lpm
AU:	39 cm
FCF:	142 lpm
Edemas:	++/4 maleolares (esperables, no signo de PE)
Reflejos osteotendinosos:	Normales
Tacto vaginal (con consentimiento):	Útero posterior, dehiscente, 50% borrado
Presentación:	Cefálica encajada en plano -2

ECOGRAFÍA RECIENTE (sem 37)

Feto único vivo en presentación cefálica. Peso fetal estimado: **3,850 g (percentil 90 — MACROSOMÍA CONFIRMADA)**. Anatomía conservada. Líquido amniótico: ILA 18 cm (normal alto). Doppler umbilical, arteria cerebral media y ducto venoso: NORMALES. Placenta grado III, sin signos de insuficiencia placentaria.

LABORATORIOS RECIENTES

Analito	Resultado	Unidad	Observación
HbA1c	5.8	%	Controlada
Hemoglobina	10.9	g/dL	Leve anemia esperable
Urocultivo	Negativo	—	Sin crecimiento

Proteinuria cualitativa	Negativo	—	Sin proteinuria
Test no estresante	Reactivo	—	Bienestar fetal conservado

DIAGNÓSTICO

1. Embarazo de 38 semanas + 2 días. 2. ****Diabetes gestacional CONTROLADA con insulina**** (HbA1c 5.8%). 3. Feto único vivo en presentación cefálica. 4. ****Macrosomía fetal**** (PFE 3,850 g, percentil 90).

PLAN — DECISIÓN DE VÍA DE PARTO

Análisis: macrosomía con PFE >4,000 g esperado al término en contexto de DG, sumado al riesgo aumentado de distocia de hombros. Antecedente de parto vaginal previo SIN complicaciones (RN 3,200 g) NO es protector ante el peso fetal proyectado.

****DECISIÓN: CESÁREA ELECTIVA** programada para semana 39** (próxima semana). Justificación: riesgo aumentado de distocia de hombros con PFE >4,000 g + DG. Referir a hospital de mayor complejidad (II-2 o III-1) por riesgo metabólico neonatal asociado a hijo de madre con DG.

INDICACIONES

1. Continuar dieta diabética + insulina hasta el día de la cirugía. Omitir dosis matutina el día de la cesárea. 2. ****Consentimiento informado**** firmado para cesárea (riesgos y beneficios explicados). 3. ****Conteo diario de movimientos fetales**** hasta la cesárea. 4. ****Test no estresante semanal**** mientras se espera. 5. Signos de alarma para acudir a emergencia obstétrica: sangrado, contracciones regulares antes de la fecha programada, pérdida de líquido amniótico, disminución de movimientos fetales, cefalea/edema súbito. 6. Cita en hospital referido para evaluación pre-quirúrgica (anestesiología, valoración cardiovascular).

Médico tratante: Dr. Juan Carlos Vásquez Torres — CMP 45821

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.